SDD 237bis Sujet n°1

Spécialité : Médecine Légale

Date : 24/02/2024
Auteur : LAURENT Marc-Antoine (DES Médecine Légale et Expertises Médicales)
Relecteur(s) : DUFAYET Laurène (MCU-PH), EPAIN Marie (AHU), FARRUGIA Audrey (MCU-PH), VILLARD Sébastien (interne DES médecine interne)

Domaine d'apprentissage principal	Interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Communication interprofessionnelle
Item(s) en lien avec la station	ITEM 13 Certificats médicaux. Décès et législation ITEM 144 Deuil normal et pathologique
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD-237 bis Décès
Matériel nécessaire à la station	- Feuille de brouillon pour le candidat - Stylo pour le candidat - Feuille de brouillon pour l'évaluateur - Stylo pour l'évaluateur - IPAD pour évaluateur
Contexte de la station	Constatation de décès à domicile

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Station avec personnel de santé standardisé

Contexte :
Vous êtes interne de médecine générale à SOS médecin.
Vous êtes appelé par une infirmière à domicile pour constater le décès de Monsieur X, 56 ans. Elle rapporte l'avoir découvert sans vie à son domicile et la porte d'entrée n'était pas verrouillée. Elle a retrouvé du sang à proximité du corps et a constaté une blessure à la tête.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :

- Rechercher les différents signes qui permettraient d'affirmer le décès
- Évoquer les causes potentielles du décès en interrogeant l'infirmière
- Énoncer et expliquer la conduite à tenir face à cette situation
- Répondre à l'interrogation de l'infirmière

Vous ne devez pas :

- Faire un examen clinique
- Rédiger un certificat médical de décès

Attention : Vous avez 8 minutes incluant la lecture des consignes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA

GRILLE D'ÉVALUATION

Aptitudes cliniques			
1.	Rechercher au moins 2 signes positifs de la mort (refroidissement cadavérique OU rigidité OU lividités)	1 pt	☐
2.	Rechercher les 3 signes négatifs de la mort : arrêt des fonctions cérébrales ET arrêt de l'activité respiratoire ET arrêt cardiovasculaire	1pt	☐
3.	Confirmer le décès à l'infirmière APRÈS avoir rechercher les signes de la mort	1 pt	☐
4.	Interroger l'infirmière sur les antécédents médico-chirurgicaux du patient	1 pt	☐
5.	Interroger l'infirmière sur le motif de ses interventions au domicile du patient	1 pt	☐
6.	Évoquer une cause médicale potentielle du décès (traumatisme crânien)	1 pt	☐
7.	Indiquer la mise en place d'un obstacle médico-légal	1 pt	☐
8.	Expliquer en quoi le décès relève d'un obstacle médico-légal (domicile non verrouillé OU traumatisme crânien visible OU mort suspecte)	1 pt	☐
9.	Savoir expliquer que suite à l'obstacle médico-légal une enquête judiciaire va être ouverte ET qu'un examen par un médecin légiste peut être demandé (autopsie, examen externe, levée de corps)	1 pt	☐
10.	Demander si la famille a été prévenue du décès	1 pt	☐

Communications et attitudes

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

7. APTITUDE À COOPÉRER avec les pairs

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Autoritaire / Difficulté à coopérer	Communique. Transmet l'information	Communique. Adopte la technique de reformulation.	Communique les renseignements pertinents. Reconnaît les obstacles à la communication. Délègue les responsabilités en respectant les autres.	Reconnaît les problèmes de communication et sait les régler avec adresse.

TOTAL	14 points

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA

SCÉNARIO DE L'INFIRMIÈRE SIMULÉE

Consignes génériques pour l'infirmière :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes appelé par une infirmière à domicile pour constater le décès de monsieur X, 56 ans. Elle rapporte l'avoir découvert sans vie à son domicile, la porte d'entrée n'était pas verrouillée. Elle a retrouvé du sang à proximité du corps et a constaté une blessure à la tête.

Plan de la station ECOS :

L'étudiant se situe en face de vous.

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

Bonjour, je suis l'infirmière qui s'occupe tous les jours de Monsieur X depuis 1 mois. Je suis arrivée chez lui et comme il ne répondait pas je me suis permise d'ouvrir la porte qui n'était pas verrouillée. Je l'ai découvert inanimé sur le sol. Il y avait du sang tout autour de lui.

Identité du patient :

Monsieur X, 56 ans.

Mode de vie :

Monsieur X est professeur des écoles, il est sportif et pratique la course à pied. Il est marié et a deux enfants. Il ne consomme pas de toxiques.

Antécédents personnels :

Il y a un mois, il a été opéré d'une fracture de la cheville droite. Il est actuellement immobilisé par un plâtre.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Antécédents familiaux :

Aucun.

Médicaments :

Prise de PARACETAMOL pour soulager les douleurs. Injection de HBPM en intra-musculaire par l'infirmière une fois par jour.

Symptômes positifs :

Si l'étudiant vous demande les signes positifs précoces de la mort faire préciser lesquels.

Si l'étudiant vous demande s'il y a un refroidissement cadavérique « *La température du corps est à 34°C.* »

Si l'étudiant vous demande s'il y a des lividités « *J'ai retrouvé des taches rouges au niveau de son dos.* »

Si l'étudiant vous demande s'il y a des rigidités « *Il n'y en a pas.* »

Si l'étudiant vous demande les signes négatifs de la vie faire préciser lesquels.

Si l'étudiant vous demande si les réflexes sont présents ou abolis « *Les réflexes sont abolis.* »

Si l'étudiant vous demande si l'individu respire « *Il n'y a pas de mouvement spontané respiratoire.* »

Si l'étudiant vous demande s'il y a un arrêt cardiaque ou s'il y a une absence de pouls « *Je ne perçois pas de pouls* »

Si l'étudiant évoque le fait de mettre un obstacle médico-légal « *Pourquoi doit-on mettre un obstacle médico-légal ? Est-ce qu'il est possible de m'expliquer ?* »

Si l'étudiant demande si la famille a été prévenue «*Oui*»

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Questions de relance :

Si l'étudiant ne confirme pas le décès de Monsieur X. au bout de 5 minutes « *Pour vous, Monsieur X est-il bien décédé ?* »

Au bout de 6 minutes ou si l'étudiant vous demande si vous avez des questions, poser la question « *Que se passe t-il ensuite lorsqu'on met un obstacle médico-légale ?* »

ECOS TACFA

FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

L'infirmière se place en face de l'étudiant.

Matériel nécessaire à la station :

- Feuille de brouillon pour le candidat
- Stylo pour le candidat
- Feuille de brouillon pour l'évaluateur
- Stylo pour l'évaluateur
- IPAD pour évaluateur

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)